跨学科团队协作在提升介入手术室护理质量中的作用研究

曲文全 李南 胡鸿雁 薛江华 温暖
（济南市中心医院，山东济南 250013）

摘要：本研究旨在探讨跨学科团队协作在提升介入手术室护理质量中的关键作用。通过分析手术室内多学科专业人员的协作模式，研究揭示了有效的团队协作对护理质量、患者安全以及手术效率的积极影响。研究采用实证分析方法，结合定量和定性数据，验证了优化沟通机制、明确角色分工和实施团队培训对减少护理差错、提高手术成功率的效果。结果表明，跨学科团队协作显著提升了手术室的工作效率、护理质量及患者术后满意度，且降低了术中并发症的发生率。通过加强信息共享、优化决策机制和团队文化建设，本研究为提升介入手术室护理管理提供了有效策略，并为跨学科团队协作理论在临床实践中的应用提供了参考和指导。

关键词：跨学科；团队协作；手术室护理质量
DOI:10.16434/j.cnki.zgzl.2025.01.017

Research on the Role of Interdisciplinary Team Collaboration in Improving the Quality of Care in Interventional Operating Rooms

QU Wenquan LI Nan HU Hongyan XUE Jianghua WEN Nuan
(Jinan Central Hospital, Shandong Jinan 250013)

Abstract: This study aims to explore the critical role of interdisciplinary team collaboration in enhancing the quality of care in interventional operating rooms. By analyzing the collaborative models of multidisciplinary professionals in the operating room, the research reveals the positive impact of effective team collaboration on care quality, patient safety, and surgical efficiency. The study adopts an empirical analysis method, combining quantitative and qualitative data to verify the effects of optimizing communication mechanisms, clarifying role responsibilities, and implementing team training on reducing nursing errors and improving surgical success rates. The results show that interdisciplinary team collaboration significantly enhances work efficiency, care quality, and patient satisfaction post-surgery, while also reducing the incidence of intraoperative complications. By strengthening information sharing, optimizing decision-making mechanisms, and fostering team culture, this study provides effective strategies for improving care management in interventional operating rooms and offers reference and guidance for the application of interdisciplinary team collaboration theory in clinical practice.

Keywords: interdisciplinary; team collaboration; operating room care quality

中国知网 https://www.cnki.net

引言

随着医疗技术的进步和手术复杂性的增加，介入手术室的护理工作面临严峻挑战[1]。手术的高风险、时间紧迫性和操作复杂性要求多学科团队，如手术医师、麻醉师、护士和放射技师，紧密协作。这种高度专业化的环境中，团队协作不仅提升了手术效率，减少了医疗差错，还改善了患者术后恢复，确保医疗服务质量[2]。然而，跨学科团队常面临沟通障碍、职责不明确和决策混乱等问题，威胁患者安全。因此，研究跨学科协作对手术室护理质量的影响并提出改进策略，具有重要现实意义。

一、跨学科团队协作理论探讨

1. 团队协作与护理质量的关系

在现代医疗中，团队协作对于提升护理质量至关重要，尤其是在介入手术室这样高度复杂且高风险的环境。团队协作保障了手术过程的安全和高效，通过信息共享、合理分工和快速决策应对复杂情况[3]。有效的沟通是关键，它使团队能够迅速应对突发状况，减少错误和意外。多学科的协作为临床决策带来更全面的视角，提升了护理的安全性和患者满意度。此外，团队合作使工作流程更加标准化，减少失误，改善患者术后的恢复。明确的职责分工也能减轻护士在高压环境中的负担，提高护理效率。因此，团队协作不仅提升了护理水平，还在改善预后、减少医疗纠纷方面发挥了重要作用。

2. 跨学科团队的定义与特点

跨学科团队由不同学科背景的专业人员组成，通常包括医师、护士、麻醉师、放射技师等，他们各自的专业知识与技能共同为患者提供全方位的护理与治疗[4]。在这样的团队中，每个成员不仅专注于自己的专业，还需要了解并尊重其他学科的工作方式与流程，从而弥补单一学科的不足，提升整体护理质量。跨学科团队的特点在于其合作的灵活性和多样性，通过信息共享和集体决策，确保患者在治疗过程中获得最佳护理。此外，团队中的角色分工更加复杂，每位成员都有明确的职责，同时也需具备跨学科的协作能力。因此，团队的成功不仅依赖于技术水平，还取决于沟通效率、文化融合度和角色认同。

3. 跨学科团队在手术室中的作用

在介入手术室这一复杂而紧张的环境中，跨学科团队协作至关重要。信息共享是关键，每位成员从不同渠道获得的信息整合有助于优化手术流程[5]。通过建立标准化的信息传递渠道，如电子病历和术前会议，确保每个专业人员及时获取关键信息，减少传递失误，提升手术安全性和准确性。

集体决策提高了手术室的决策效率。复杂手术中的任何细微变化都会影响结果，多学科意见的融入有助于全面评估风险并制定最佳方案。放射技师提供影像支持，麻醉师监控生命体征，护士管理手术器械和患者护理，各环节紧密配合，确保手术成功和患者安全。

此外，团队协作能显著改善护理质量。定期培训和模拟演练增强了协作意识和紧急反应能力，完善的沟通和决策机制提升了手术的连贯性和效率，从而进一步优化了术后护理质量。因此，跨学科团队不仅支持手术操作，也在护理质量提升中发挥了重要作用。

二、介入手术室护理质量的提升因素分析

1. 护理质量评估指标

评估介入手术室护理质量时，主要指标包括患者安全、护理效率和患者满意度。这些标准不仅反映护理整体表现，还揭示跨学科团队协作的有效性。患者安全是首要标准，涵盖术中和术后并发症、医疗错误等。跨学科团队通过信息共享和集体决策，有助于减少护理失误，提升安全保障。

护理效率则衡量团队在有限资源下完成复杂任务的能力。合理的资源分配和流程优化提高了各环节的协调性，使护理工作更加高效、顺畅。患者满意度则反映了患者对护理服务的主观体验。通过优化流程、加快术后恢复和提高响应速度，跨学科协作能够

中国知网 https://www.cnki.net

显著提升患者满意度。

2. 团队沟通对护理质量的影响

团队间有效沟通对护理质量至关重要，尤其在手术室中，沟通的准确性和连贯性决定了护理工作的顺畅。如果沟通不及时或信息传递不完整，可能引发误解和错误，甚至危及患者安全。比如，医生与护士未及时交流患者情况，可能导致护理措施未及时调整，增加术后并发症的风险。

实际案例表明，良好的团队沟通显著提升了护理精准度与效率。通过标准化沟通工具和流程，如术前简报和术后反馈会议，团队能迅速传递关键信息，减少误解。同时，开放和信任的团队文化鼓励成员积极分享信息，降低沟通障碍，从而提高团队协作的整体水平。

3. 决策机制与角色分配对护理效率的影响

在跨学科团队中，合理的决策流程和明确的角色分工是提高护理效率和质量的关键。在手术室，团队成员各司其职，履行明确职责并参与决策，确保责任清晰，避免重叠或遗漏。当角色分配不明确时，护理任务效率会降低，影响协作和护理质量。

多元化的决策流程能提升决策质量，不同学科成员提供专业意见，通过集体讨论做出全面的决策，避免单一视角的局限。在复杂的介入手术中，放射科提供影像支持，麻醉师监控生命体征，护士负责器械管理和患者护理。全方位的参与助力团队更准确地评估风险，优化护理方案，从而提升整体护理质量。通过优化角色分配和决策流程，团队协作能够有效提升手术室护理水平。

三、跨学科团队协作的障碍与挑战

1. 沟通障碍

有效的沟通是跨学科团队协作的核心，但在实际操作中，沟通障碍常常影响协作效率和护理质量。不同专业领域有其独特的术语和表达方式，这种语言差异是主要障碍之一。医生、护士、麻醉师、技师等使用不同的专业术语，可能导致信息传递中的误解或失真。例如，医生使用复杂医学术语描述病情，而护理人员可能无法准确理解，进而影响护理措施的精准性和及时性。

此外，信息传递效率低下也是一大问题。介入手术室环境复杂且紧张，信息的快速、准确传递至关重要。然而，由于跨学科团队成员背景各异，沟通不畅时常发生，尤其在紧急情况下，信息未能及时、有效传达，导致决策延误或错误，影响患者安全。研究表明，沟通过程中的细微失误可能引发严重的医疗后果，增加护理差错和手术并发症的风险。因此，提升沟通效率是优化团队协作的关键。

2. 角色不明确和职责重叠

跨学科团队中的角色分工不明确会直接影响协作效率和护理质量。明确的职责分工有助于避免工作重叠和模糊，但在实践中，团队成员对自身职责的理解常常不一，特别是在紧急情况下，分工容易混乱。角色分配不明确不仅降低工作效率，还可能导致决策失误。例如，护士可能认为某项任务应由医生负责，而医生则认为该任务应由护理团队执行，结果任务无人承担，影响护理质量。

职责重叠也可能导致角色模糊和责任推诿。在多学科团队中，尤其在紧急和复杂的手术过程中，职责交叉时常出现，责任不清会引发错误的决策，并对患者安全构成威胁。模糊的角色分工还会削弱团队成员的协作意识，降低整体护理效果。因此，明确每个成员的职责、确保合理的角色分配，是提升护理质量的关键。

3. 组织文化与团队协作效率的矛盾

医院的组织文化对跨学科团队的协作效率有重要影响。不同学科之间的专业文化差异，常常成为团队协作的障碍。每个学科都有特定的工作方式和价值观，这些文化差异在团队协作时可能引发冲突。例如，外科医生倾向于关注手术效率和技术精确性，而护理团队更注重患者的整体照护和心理需求，这种不同的优先级理解可能影响协作的顺畅性。

此外，医院的权力结构也影响团队协作效率。

中国知网 https://www.cnki.net

在传统的医疗层级中，医生处于权力金字塔的顶端，而护理人员、技师等则处于较低层级。这种等级结构可能导致跨学科团队内的沟通不平等，某些成员的意见可能被忽视或低估，进而削弱团队的协作效果。

四、跨学科团队协作的优化策略与实践建议

1. 优化沟通机制

为解决跨学科团队中的沟通障碍，需要采取多种策略以优化信息流动。定期的团队培训是关键，通过培训可以提升团队成员的沟通技巧，特别是在紧急情况下的信息传递能力。培训内容应注重简洁明了的沟通技巧，减少使用可能导致混淆的专业术语，同时鼓励开放性和积极倾听。医院还应引入信息共享平台，如数字化电子病历系统，确保团队成员随时获取最新的患者信息，减少信息遗漏和延迟，确保所有团队成员都同步掌握手术进展和护理需求。

此外，使用协作工具如即时通讯应用和手术管理系统，也可以提高团队间的沟通效率。这些工具能够简化信息传递，减少错误的发生。通过术前会议和术后讨论会等标准化的沟通流程，团队成员能够在固定的时间和渠道内充分讨论手术中的问题，确保信息透明并提高协作效果。

2. 明确角色与职责分工

优化跨学科团队的协作，明确的角色分工至关重要。角色模拟训练是帮助团队成员理解自己及他人职责的有效方法。通过角色扮演和场景模拟，团队可以预见并解决可能的职责重叠或遗漏问题。例如，护士可以通过模拟场景，更好地理解如何在手术中支持医生；医生也可以通过这种训练加强与护理人员的协作，减少不必要的沟通失误和任务重叠。

建立标准化的操作流程和职责分配体系也是优化分工的关键。明确的工作手册和流程确保团队成员清楚了解自己的责任，并与其他成员顺畅合作。这样不仅避免了职责重叠，还确保团队成员在紧急情况下知道自己的优先任务，从而提升整体效率。团队管理中，定期评估每个成员的职责分配是否合理，并根据手术的复杂性和成员经验进行调整，确保团队动态高效运作。

3. 建立团队建设和培训机制

定期的团队建设活动和跨学科培训能够显著增强协作意识和技能。培训内容应包括情景模拟、角色互换和实际操作等环节。情景模拟能让团队成员在无压力的环境中处理复杂情境，提升在实际手术中的反应能力和协作水平。通过模拟紧急手术场景，成员可以了解如何在压力下进行高效协作，明确各角色在团队中的贡献。

角色互换也是提高团队协作的有效方法。通过体验不同的角色职责，团队成员可以更好地理解其他专业的需求和挑战。例如，护士可以体验医生的决策压力，医生则可以体会护理工作中的实际困难，从而建立相互理解与尊重。团队建设还应包括实地操作培训，帮助成员熟悉手术设备和工具，增强工作中的默契，减少操作中的意外与失误。

4. 增强组织支持与领导力

团队协作的优化不仅依赖于成员的努力，还需要组织层面的支持和领导力的有效引导。医院管理层应推动跨学科协作文化，鼓励不同科室的成员参与团队建设，并为其提供必要的资源与工具。管理层应提供更多培训机会及先进的沟通工具，以促进团队内外的有效协作。

领导力在团队协作中扮演着重要角色。通过定期的领导力培训，管理者可以引导团队在面临挑战时保持一致，并通过激励机制提升团队成员的协作动力。有效的领导能够确保团队成员在遇到问题时积极沟通与解决，推动团队协作向更高效的方向发展。

五、实证分析

1. 案例背景与研究方法

本案例选取了为期3个月的介入手术室团队改进项目。团队由12名核心成员组成，包括3名主刀医生、2名麻醉师、5名护士和2名放射技师。项目开始

中国知网 https://www.cnki.net

前，团队在术前沟通、角色分工及术中决策方面存在问题，影响了信息传递和护理质量。

为改善协作，项目采取了多项干预措施，如引入标准化沟通工具、定期术前会议、术中即时通讯工具以及角色分工培训。数据包括术前后护理质量评价、团队成员满意度调查和护理差错率，通过问卷、访谈及术中记录，对比协作优化前后的效果。

2. 研究结果与数据分析

团队对优化措施实施前后的数据进行了详细对比（见表1）。

表1　优化措施前后的数据对比

指标	优化前	优化后
平均手术时间（分钟）	99	88
护理差错次数（每月）	8	3
患者满意度评分（满分100）	78	91
术前沟通时间（分钟）	15	10
团队协作满意度（满分10）	6.5	8.7
患者并发症发生率（%）	12	6

3. 案例分析与讨论

数据分析显示，跨学科团队协作显著提升了手术室护理质量。通过术前会议和即时通讯工具，团队成员快速传递关键信息，显著减少手术中的信息错误。沟通时间缩短优化了手术准备，提升了团队满意度。

明确角色分工减少了术中护理差错和延误。角色模拟训练增强了团队成员的职责清晰度，提高了操作中的效率和自信。术后护理的规范化管理和团队协作优化提升了患者满意度，并显著减少了并发症，提高了护理安全性。

4. 局限性与未来方向

尽管取得积极结果，本研究样本量有限，仅限于单一医院的介入手术室，不足以代表其他场景。未来研究应探索如何维持改进效果，并可能引入人工智能（AI）辅助系统，以提高团队协作的效率和精确度。

本研究验证了跨学科团队协作在提升介入手术室护理质量中的关键作用，强调了有效沟通、明确的角色分配和持续的团队培训的重要性。

六、小结

本研究探讨了跨学科团队合作在提升手术室护理质量中的关键作用，指出其对护理质量和患者安全的深远影响。研究表明，优化团队协作显著提高了沟通效率，减少了护理失误，提升了患者满意度。通过标准化沟通流程、明确分工和定期培训，团队协作效率得到大幅提升，使手术过程更加顺畅，并有效改善护理质量。

研究还发现，跨学科团队合作在减少手术并发症、缩短手术时间和提升护理效率方面成效显著。精准的信息传递和清晰的职责分配使团队能够快速应对突发情况，降低了医疗错误，提升了手术成功率。这种协作模式为临床实践中推广跨学科团队合作提供了有力支持。

未来的研究应在更多样化的医疗环境中验证这些方法，并结合人工智能等技术，进一步完善团队合作机制，以持续提升护理质量和患者安全。CAQ

参考文献

[1] 郭露影，李晴.手术室护理人员团队协作与工作满意度相关性研究[J].现代消化及介入诊疗，2019（A01）：2.

[2] 徐海英，贺艳，蔡英华，等.多部门协作的手术室精益化管理研究[J].护理学杂志，2019，34（10）：4.DOI:CNKI:SUN:HLXZ.0.2019-10-018.

[3] 罗玲.团队护理模式在手术室风险管理中的应用价值[J].中外女性健康研究，2019（6）：2.DOI:CNKI:SUN:ZWVJ.0.2019-06-126.

[4] 于爱武.团队合作模式在手术室护理质量持续改进中的作用[J].心理月刊，2020（015）：000.DOI:10.19738/j.cnki.psy.2020.15.106.

[5] 张白易，蒋芳琴，张新梅，等.团队合作模式在手术室护理质量持续改进中的作用[J].当代护士（综合版），2019，026（10）：123—124.

注：基金项目跨学科团队协作在提升介入手术室护理质量中的作用研究，课题编号2024205004。

中国知网 https://www.cnki.net